

on voit que tout le système digestif est bien suspendu à la base du crâne. Ça veut dire qu'il y a un mouvement très important qu'on appelle le mouvement entre le sacrum et l'occipute, qui est un mouvement de vie, un mouvement de balance, qui soutient la santé. Si j'ai trop de tension, ici je peux perturber mon système crâne sacré. Ça veut dire qu'on a ici votre sternum, et on a vu que finalement l'embryon faisait un mouvement global dans son développement, où la plaque tournante s'exprimait sur mon sternum. Ça veut dire que non seulement j'ai un système crânio-sterno sacré, et on va rajouter plus tard dans le développement crânio-sterno sacré mandibulaire, qui est aussi une phase d'expansion, qui est aussi une phase de rétraction, qui est aussi une phase d'inspiration, qui est aussi la phase d'expansion. Les dents, la base des dents, va influencer, va donner la cartographie de la base du crâne, qui contient, je vous rappelle, dans ce plan sphénoïdal, une glande qui en rapport avec mon épiphyse, est une glande qui soutient le processus hormonal. Ça veut dire que c'est un axe global sur tout mon plan hormonal. On est des êtres hormonaux. On est complètement dépendant de nos glandes. Epiphys, hypophys, thyroïde, surrénal, gonadique. Cet axe est fondamental. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de bien comprendre l'équilibre entre mon système thyroïdien et surrénalien. Ce sont des systèmes d'adaptation. Donc nerveux, vasculaire, glandulaire. Et le système glandulaire, dans sa bonne fonction, sera dépendant du système conjonctif. Ça veut dire que pour libérer un système conjonctif, libérer un système endocrine, je dois travailler sur mon tissu facial, alimentaire. N'oubliez pas qu'il y avait une chronologie d'apparition. Donc on retient déjà que tout le système digestif est suspendu à la base du crâne. On peut imaginer ça comme une corte où je fais sonner la cloche. Et bien mon système... Le système digestif est suspendu. Et on va voir comment c'est suspendu par le système facial jusqu'à ma base du crâne. On a un tissu qui se

divise en un tissu de limite et un tissu d'intérieur. Ça veut dire que le plus important ici sera mon tissu de limite. On va étudier dans ce tissu limite l'endoderme. Et on voit que l'endoderme, finalement, c'est un épithélium. C'est un tissu de frontière. Donc c'est un tissu d'échange. Avec mon mésoderme, c'est lui qui contient l'information primaire. C'est la voie royale. J'en change par ceci. Le tissu, c'est un tissu d'épithélium. Comme l'ectoderme, c'est un tissu épithélium. Donc c'est pour ça que c'est un tissu de limite. Dans le tissu de limite, il n'existe jamais, jamais de congestion. Les congestions se traitent toujours sur le plan mésodermique. Donc notre tissu, à nous, c'est le tissu mésodermique. Et là, il porte quoi ? Il porte entre autres tous vos systèmes vasculaires. Deuxième chose qui est importante. Le tissu endodermique, le tissu épithélium, qu'il soit de frontière, de type endodermique, ou de frontière, ou de limite, de type ectodermique, c'est lui qui porte le système glandulaire. En d'autres mots, toutes les glandes, dérivent toujours de ton tissu de limite. Donc toutes les glandes, c'est toujours un tissu qui a une origine épithéliale. Tu as de nombreuses glandes. On peut considérer que, par exemple, au niveau thyroïdien, c'est une glande. Mais on peut considérer que tes poumons, c'est une glande. On peut considérer que ton foie est une glande. Ce sont des expansions de ton tube épithélial. C'est un endoderme épithélial. Donc bien considérer que mon endoderme va donner, et que mon ectoderme, via mon système épithélial, porte mon plan hormonal. N'oubliez pas, le système hormonal, il va profondément dans le corps, il est dépendant de mon système, entre autres, beaucoup digestif ou ectodermique. Beaucoup digestif. C'est cette phrase-là, c'est ça qu'il faut retenir. Le tissu d'intérieur est à la fois le moteur et la résistance à la croissance pour limiter les tissus dans leur développement. Je vais appeler ça l'algorithme pour le développement. C'est-à-dire que c'est un système répétitif. Ça veut dire qu'à un moment donné, les vitesses de croissance ne font pas la

même vitesse dans le tissu. Et ces vitesses de croissance vont nous donner des points d'appui. Qui sont des points, ce qu'on appelle des Hitchpons. Quand tu as des Hitchpons, tu as des points charnières d'organisation générale. Et nous, le corps, on a besoin, le corps, il sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de problème pour lui. Par contre, nous, on doit soutenir son processus. Et pour soutenir son processus, on doit revenir sur des qualités ontogénétiques. Des qualités où le tissu peut se réorganiser. Un fulcrum, c'est un point. Pour la création d'une forme et qui reste toujours présente. Par exemple, c'est un fulcrum aussi entre un point de balance. Entre un moment où j'ai un changement. Première grande articulation dans le corps. J'ai mon système vasculaire. C'est-à-dire mes deux vaisseaux primitifs qui sont là. Le tissu d'intérieur. A savoir, le tissu mésodermique. Qu'est-ce qu'il contient, le tissu mésodermique ? Il contient des vaisseaux. Ces vaisseaux vont se développer dans un embryon de façon précoce. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai ma notocorde, je vois apparaître latéralement, par amort à ma plaque neurale, une réorganisation de mon système fluide du corps. Donc cette réintégration de mon système fluide fait que mon système d'intérieur, lui, il amène l'énergie. Donc c'est un moteur. Mais il ne grandit pas à la main visuelle. Il est à la vitesse. Donc c'est un frein. Mon ectoderme qui est derrière, il grandit super vite. Parce qu'il est super nourri. OK ? Donc, moi, je représente mon ectoderme. Ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois mon cœur, ou la zone de congestion cardiaque primitive, qui est au-dessus d'abord de ma tête. C'est-à-dire dans la partie caudale de mon embryon. L'ectoderme qui est mon corps grandit. Beaucoup plus vite qu'ici. Je grandis. Et il y a un frein ici devant. Et bien je viens m'enrouler autour de ma zone cardiaque. Marche arrière. Si vous regardez, le cœur, ici, en voie de développement, il ne grandit pas à la même vitesse. Donc il devient un point d'appui global pour le développement. Ça veut dire que mon premier fulcrum va être sur ce

cœur. Et ma symphyse phénobasilaire. Ce mouvement global de développement, devient comme un plan d'organisation, comme un plan d'articulation. Et vous allez voir que toutes mes articulations ne sont que la répétition séquentielle du même processus de cet algorithme. Un rein sur un foie, c'est une articulation. Un poumon sur un diaphragme, un poumon sur un cœur, ce sont des phases d'articulation. Pourquoi je sais fléchir comme ça ? Et pourquoi je ne sais pas fléchir par là ? Parce que j'ai un olécrane. Mais avant, il n'y avait pas d'olécrane. Pourtant, j'ai quand même été par là. Pourquoi ? Je m'enroule vers mon système vasculaire. Ici, j'ai une artère. Là, je n'en ai pas. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Si j'avais une artère ici, j'aurais la capacité d'aller par là. Et regardez ici, c'est la même chose. Et vous voyez, qu'est-ce que fait un petit embryon au départ ? Il vient s'enrouler comme ça. Et tu vas voir que ton cerveau, il va suivre des champs vasculaires de développement. La dernière fois, on avait étudié ce développement du cerveau. On avait fait le tai-chi du cerveau. Vous vous souvenez ? On va le refaire après. Et on va l'intégrer cette fois-ci avec le système digestif. Parce que non seulement ce qui se passe là, vient se passer ici de façon synchrone. Et on va commencer à voir que ce qui se passe ici, peut être un phénomène qui se bloque là. Et qu'aller traiter par exemple une ligne ici, ce sera libérer une articulation viscérale. Le nombril. Vous êtes maintenu complètement ici. Au moment où vous rentrez dans la terre utérine, que vous vous incarnez, ce premier moment, ce premier contact, c'est cette recherche ici. C'est un contact énorme. Et ça se fait toujours dans un pôle bien spécifique. Vous vous rappelez ? Ça se fait toujours sur un plan assimilateur. Ça veut dire que c'est un plan... Vous vous souvenez, j'avais parlé de la polarité. On avait parlé de la polarité. Que l'une des premières choses... que l'embryon faisait, c'était la polarité. Au moment où je rentre dans cette muqueuse, je rentre par un champ électrique, électromagnétique organisé. Je ne

rentre pas de façon désorganisée. Je rentre toujours de la même façon. Par mon plan assimilateur. Par le plan où je recherche l'information trophique. Donc j'arrive, toc, ce premier contact, c'est un contact important avec la mère. Pédicule embryonnaire. Et que le cordon ombilical final, sera le vestige ici, de la vésicule viteline, avec le pédicule embryonnaire. Les deux ensemble vont former ce cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, l'ombilique ici, sera la rencontre entre cette phase primitive d'intégration de ton incarnation dans la chair utérine, avec ce premier contact qui va se faire. Et puis on va voir plus tard avec la mise en place de ma cavité, de l'intégration de mon cellome externe en un cellome interne. Et plus spécifiquement, encore avant, c'est la mise en place de la membrane de Heusser, avec la mise en place de ma vésicule viteline et de mon cellome externe. Qui allait former cette S d'organisation autocordale primitif, qui redonnait l'intégration vers mon attache, au niveau de mon cellome externe. Je m'attache au niveau de mon système global. Parce que votre intestin et votre corps, c'est un symbole. Et ils portent la symbolisation de vos mots. Tu as réalisé ton symbole ou tu es resté dans ton diabol. Je suis dispersé ou je suis concentré, rassemblé. J'ai pu me rassembler et beaucoup de gens sont encore dans le diabolisme de leur intégration. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le symbole. Beaucoup de gens qui partent du symbole.